طبع فى 24/10/2026 23:32:21

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : زينب احمد عبدالكريم احمد

المحافظة : القليوبيه　**الحي / المدينة :** شبرا الخيمه　**العنوان :** ش داير الناحيه القبليه

رقم البطاقة : 26504022700142　**رقم التليفون :** 01126999719　**تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 02-04-1965 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي　　**المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------)　　**التوقيع:(--------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129]　**قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني　**الوظيفة:** ---------------------------　**التوقيع:** د/محمد كيلاني

الاسم: د/ندى حسن　**الوظيفة:** ---------------------------　**التوقيع:** د/ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان　**الوظيفة:** ---------------------------　**التوقيع:** نرمين رمضان

جوستاف روسي

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ -----------------------　**ا.د/** -----------------------　**د/** -----------------------　**د/** -----------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ---

خطة العلاج : ---

المستشفي : --- **قسم :** ---

جهة العلاج : --- **نفقات :** ---

ملاحظات : ---

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: زينب احمد عبدالكريم احمد
National ID: 26504022700142

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

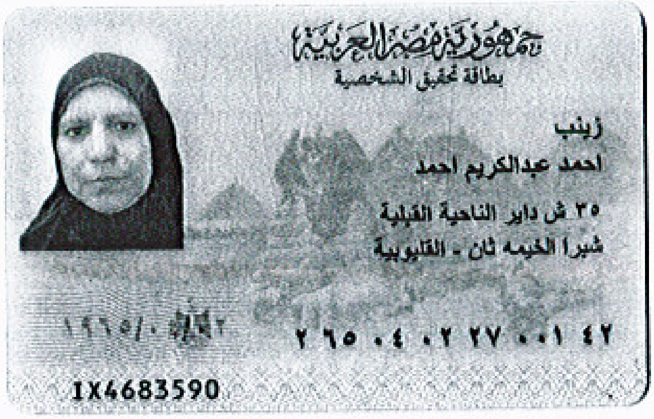
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis**،

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

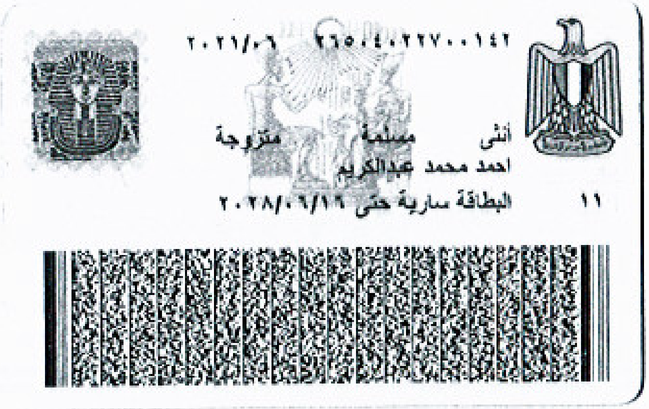


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

زينب
احمد عبدالكريم احمد
٢٥ ش داير الناحية القبلية
شبرا الخيمه ثان - القليوبية

١٩٦٥/٠٤/٠٢
٢٦٥٠٤٠٢٢٧٠٠١٤٢
1X4683590

فيصل
زوجتي



٢٠٢١/٠٦ ٢٦٥٠٤٠٢٢٧٠٠١٤٢
أنثى مسلمة متزوجة
احمد محمد عبدالكريم
١١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٦/١٩

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

(GA)

1/9/2022

Name	زينب أحمد عبدالكريم	MRN	٥١٣/٢٢
Age	٥٥ سنة	ID	٢٦٥٠٤٠٢٢٧٠٠١٤٢
Menopausal status		Phone	٠١١١١٣٦٠٨٢٩
OCP		marital status	٠١١٢٦٩٩٩٧١٩
Co morbidity		Familyhistory	

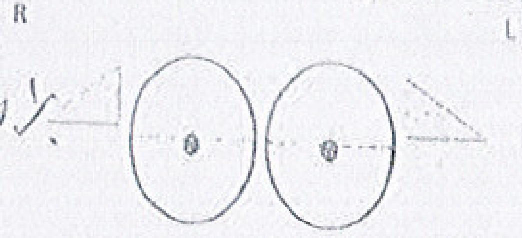
Clinical Data

Bx: IDC GII

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
8/8	0/8	Amplified	20%

Sonomammography : "PPR" Post NACT Rt. MRM free margins LN (1/17)

Mets Workup:



T N M

Recommendations:

Inv e cT4b , N2 , → recd NACT HP x 5 cycles → Rt MRM → ypT4 - ypN 1/17.

MDT OUTCOME & PLAN

- in view of partial pathologic Respn (ypT1 - ypN1.
- for Kadcyla. for 14 cycles
- PORT
- H. all AI for 5 yr. , Proka (6mn)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

٢٠٢٢/٩/١

Patient Name : الأستاذه / زينب احمد عبدالكريم احمد
Patient No. : 26504022700142
Path No. : C-472/24
Sex : Female
Age : 56 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13005355
Request Date : 14/12/2024
Verification Date : 30/12/2024
Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right thyroid nodule, TIRADS 5.
Nature of Specimen: Cytology.

Gross Examination:
- Four alcohol fixed smear slides were received.

Microscopic Examination:
Smears examined showed multiple clusters of bland follicular epithelial cells arranged in macrofollicles. Focal colloid material was seen. No atypia or papillary nuclear features were noted. There is no evidence of cytologic malignancy in smears examined.

Diagnosis.
Right thyroid nodule, Cytology:
Benign follicular lesion, Bethesda category II.

Signature
Prof. Dr. Amal Hareedy.
Dr. Yasmine Esam.
Dr. Rufaida Abdullah.

Verified by :

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : الأستاذه / زينب احمد عبدالكريم احمد
Patient No. : 26504022700142
Path No. : 248/22
Sex : Female
Age : 54 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13001107
Request Date : 26/01/2022
Verification Date : 19/02/2022
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass

Nature of the specimen: Tru-cut biopsy

Gross Examination:
4 Greyish white tissue cores, up to 1cm, totally submitted.
- Procedure: Tru-cut biopsy
- Immunohistochemical tecnique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5), &Ki67 (30-9)

Inform Her2 Dual ISH DNA Probe cocktail.

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (2+2+[illegible])

Diagnosis:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma GII

- IPT:

ER: Strong nuclear reaction in about 80% of tumour cells. Positive (Allred score 8/8)
PR: No nuclear reaction in tumour cells. Negative (Allred score 0/8)
Her-2: Strong incomplete membrane reaction in 10% of tumour cells. Equivocal , score 2+
SISH: Amplified, HER2 gene copy number= 4.5 and HER2/ CEP 17 ratio= 2.5.
KI67: Positive in 20% of the tumor cells.

Prof. Aml Hareedy
Dr. Menna Atef

Verified by :

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذه / زينب احمد عبدالكريم احمد	Request No.	: 13004543
Patient No.	: 26504022700142	Request Date	: 13/08/2022
Path No.	: 2309/22	Verification Date	: 23/08/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: dr.Enas

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast cancer; Post NACT.

Nature of the specimen:
MRM.

Gross Examination:
- Procedure: RT MRM specimen measured 18x9x4cm, covering skin measured 18x9cm, axillary extension measured 11x4x2cm.
- Tumor extent: An ill-defined greyish white rubbery tumour bed site.
o Size: 3.5x2x1.5cm.
- Distance from margins: 1cm away from deep margin.
- Lymph nodes number and size: 17 LNs, up to 2x0.5cm.

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma, largest tumour diameter is 0.5cm. (cellularity 15%).
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: No.
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in (1/17) LNs, without extracapsular invasion.
- Resection Margins: Free deep margin.
- Free nipple.
- Histologic response to therapy: Pathological partial response.
- Additional pathologic findings: No.

Diagnosis:
Right breast cancer; MRM:

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name : الأستاذه / زينب احمد عبدالكريم احمد
Patient No. : 26504022700142
Path No. : 2309/22
Sex : Female
Age : 54 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13004543
Request Date : 13/08/2022
Verification Date : 23/08/2022
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : dr.Enas

Pathology Report

-Invasive duct carcinoma GII, largest tumour diameter is 0.5cm, (cellularity 15%).
-Positive metastatic deposits in (1/17) LNs, without extracapsular invasion.
-Free deep margin & nipple.
-Pathological partial response.
-Stage: ypT1, ypN1
-Residual Cancer Burden is 2.9; CLASS: RCB-II

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Abdulrahman Ibrahim

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient's Name: ZEINAB AHMED A. EL KEREEM
Date: 2026-04-15
Referred by: Prof Dr
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post right MRM & ALAND, followed by hormonal therapy for two years, routine follow up.

Findings:

Left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections..
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion:-

Left breast (BIRADS 1): normal study.
Clear right mastectomy bed and axilla.

Recommendation:-

For annual follow up.

Best Regards,
DR. Amal Hegazi, M.Sc.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient's Name: Zainab Ahmed Abdelkereem Ahmed
Date: 2026-04-27
Referred by: Prof.Dr. CAPwithC
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST WITH CORONAL RECONSTRUCTION: -

Findings:

- Right mastectomy with surgical bed scarring tissue.
- The anterior subpleural right upper lobe shows traction brochiectatic changes. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- ***Right upper lobe post therapeutic changes.***

MULTI-SLICE CT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS AFTER BOTH ORAL & I.V. CONTRAST ADMINISTRATION: -

Findings:

- The liver is enlarged in size with low homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- The spleen is enlarged in size with no focal lesions seen.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient's Name: Zainab Ahmed Abdelkereem Ahmed
Date: 2026-04-27
Referred by: Prof.Dr. CAPwithC
Hospital: **Goustave Roussey International Egypt**

- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

Opinion:
Fatty hepatomegaly.
Splenomegaly.

Dr Mai Mohamed MD

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]